

1 実践チェックリスト(保険薬局/病院)

保険薬局薬剤師

- ☐ カペシタビン・FTD/TPI・レゴラフェニブの服用日・休薬日と残薬の管理
- ☐ ワルファリン等の併用薬、市販の下痢止め・サブリの確認
- ☐ 電話フォローで下痢・発熱・ポンプ抜針後の状況を確認
- ☐ 手足症候群・皮疹のスキンケア指導と外用薬の使い方
- ☐ 症状をGradeで記録し、トレーシングレポートで病院へ

病院薬剤師

- ☐ RAS/BRAF/MSI・UGT1A1の結果とレジメンの整合性の監査
- ☐ オキサリプラチン・イリノテカンの投与量と前投薬の確認
- ☐ 携帯型ポンプ(5-FU持続静注)の準備と使い方の説明
- ☐ 周術期の抗VEGF薬の休薬期間の管理
- ☐ お薬手帳へのレジメン情報・投与日の記載

病院と共有する情報

バイオマーカー・レジメン

検査値(好中球数・Mg・尿蛋白)

下痢・手足症候群のGrade

服用状況・家庭血圧

2 主なレジメンと薬局での確認ポイント

レジメン	構成・スケジュール	薬局での確認ポイント
mFOLFOX6	オキサリプラチン+5-FU(46時間持続静注)等、2週毎	ポンプの抜針日、寒冷刺激による急性のしびれ
CAPOX	オキサリプラチン+カペシタビン1～14日目、3週毎	休薬期間、手足症候群、ワルファリン併用時のINR
FOLFIRI	イリノテカン+5-FU(46時間持続静注)等、2週毎	遅発性下痢時の下痢止めの使い方、UGT1A1
FTD/TPI	1～5日目・8～12日目、4週毎(±バシズマブ)	食後服用(空腹時は好中球減少が増強)、骨髄抑制
レゴラフェニブ	1～21日目、4週毎(低用量から漸増する方法も)	低脂肪食後、手足症候群、初期2か月の肝機能・血圧

3 相互作用・併用注意(他院処方・市販薬・サプリを含む)

重要度	薬剤(機序)	相手の薬(区分)	起こること	薬局での対応
禁忌	イリノテカン UGT1A1阻害	処方薬 アタザナビル(抗HIV薬)	SN-38↑→骨髄抑制・下痢が重篤化	併用しない。他院処方をお薬手帳で確認
禁忌	S-1 DPD阻害(ギメラシル)	処方薬 他のフッ化ピリミジン系 (カペシタビン・5-FU等)	5-FU濃度↑→重篤な骨髄抑制・下痢	切り替え時は7日以上空ける
注意	カペシタビン・S-1 CYP2C9の抑制	処方薬 ワルファリン・フェニトイン	INR↑(出血)・フェニトイン中毒	INR測定を処方医と確認
注意	レゴラフェニブ CYP3A4阻害・誘導	処方薬・サプリ・食品 アゾール系抗真菌薬・グレープフルーツ等	副作用↑・効果↓	他院の抗真菌薬・食品の摂取を確認
注意	イリノテカン CYP3A4誘導	サプリ・食品 セイヨウオトギリソウ含有サプリ	SN-38↓→効果が減弱	サプリ・健康食品の使用を聴取
確認	止瀉薬(ロペラミド) 過量・症状を隠す	市販薬 市販の下痢止め	腸閉塞・感染性腸炎の見逃し	下痢止めの使用量と回数を確認

4 服薬指導の声かけ例と確認のタイミング

治療開始前

「冷たい物に触れると、指先やのどがピリッすることがあります。手袋や常温の飲み物で予防しましょう」

確認:お薬手帳でRAS/BRAF/MSI・UGT1A1、併用薬(ワルファリン・フェニトイン)

△ワルファリン併用中はINR測定の予定を確認

投与後～5日

「水のような下痢が1日4回以上増えたら、下痢止めを指示どおりに使い、連絡してください」

確認:電話フォローで下痢の回数・水分量、携帯型ポンプの抜針

△水様便が止まらない・発熱を伴う時は至急連絡

投与後1～2週

「37.5℃以上の熱が出たら、解熱剤で様子を見ずに、すぐ病院へ連絡してください」

確認:nadir期の発熱・口内炎、カペシタビンの服用日数

△発熱・悪寒はFNを疑い夜間休日でも受診

次回来局時

「手足の赤みや痛み、ボタンが留めにくいなどの変化はありませんか」

確認:手足症候群・しびれのGrade、家庭血圧・尿蛋白、皮疹

△Grade2以上はトレーシングレポートで共有